

Task 2: Нейросифіліс. Вібраційна чутливість(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Гнатюк Ірина Михайлівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)
- 2. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Визначити вміння проведення оцінки вібраційної чутливості
Обладнання:

- 1. Камертон 128 Гц
- 2. Камертон 64 Гц
- 3. Кушетка
- 4. Молоточок неврологічний

Витратні матеріали:

№	Ім'я	Quantity per one task execution
1	Антисептик	100
2	Серветки	1

Брифінг

Ви лікар невропатолог у поліклінічному відділенні. До вас звернулася пацієнтка 62 роки зі скаргами на відчуття оніміння та слабкість у нижніх кінцівках, відчуття нестійкості при ході особливо в темряві, падіння при закриванні очей.

ok

Текст завдання

До вас звернулася 62-річна пацієнтка зі скаргами на оніміння та слабкість у ногах, відчуття нестійкості при ходьбі, особливо в темряві. Вона також зазначає, що останнім часом часто спотикається та не завжди може точно сказати, на що стає ногою. В анамнезі – перенесений сифіліс 20 років тому. Об'єктивно відсутність ахіллових і колінних рефлексів, позитивний симптом Ромберга, спонтанні гострі стріляючі болі в ногах, зіниці Аргайла Робертсона. Лабораторно: RPR, ТРНА – позитивні, люмбальна пункція: підвищений рівень білка.

- 1. Проведіть тест на вібраційну чутливість (використовуючи відповідний камертон).
- 2. Визначте рівень випадіння чутливості та сформулюйте синдромальний діагноз.
- 3. Запропонуйте тактику ведення.

ok

Чеклист

1. -Привітатися з пацієнткою, представитися, запитати як можна звертатися до пацієнтки Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Запитати що вас турбує, виділити провідні синдроми Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Пояснити пацієнтці що для уточнення діагнозу та визначення рівня ураження нервової системи вам необхідно провести неврологічний огляд. Значення: 6%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

4. -Обрати вірний інструмент (камертон 128 Гц), пояснити пацієнту навіщо він, що ви будете робити. Значення: 6%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Попросити пацієнта зняти взуття та лягти на кушетку Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Сказати зараз я викличу вібрацію в камертоні та прикладу до кісткових виступів ви маєте сказати коли повністю перестанете відчувати вібрацію Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Прикласти камертон до шилоподібного відростку променевої кістки ліворуч та праворуч, попросити сказати коли перестане відчувати вібрацію Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Прикласти камертон до дистальної фаланги пальця кисті по черзі праворуч та ліворуч, нагадати сказати коли перестане відчувати вібрацію Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Зафіксувати результати Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Прикласти камертон до медіальної щиколодки по черзі праворуч та ліворуч, запитати коли перестане відчувати вібрацію Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. -Прикласти камертон по черзі праворуч та ліворуч до дистальних фаланг пальців стопи, зафіксувати результати Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
12. -Встановити синдромальний діагноз, яка структура уражена. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
13. -Встановити остаточний діагноз. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
14. -Скерувати пацієнта на консультацію до суміжного спеціаліста Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
15. -Пояснити необхідність чи відсутність необхідності повторної консультації, попрощатися з пацієнтом. Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

№	Лікар	Пацієнт
1.	Добрий день, мене звати ..., я лікар невропатолог. Як я можу до вас звертатись?	Добрий день, мене звати Юля.
2.	Юлія, розкажіть будь ласка що вас турбує?	Мене турбує сильна слабкість в ногах, коли ходжу в мене відчуття ніби я не відчуваю де я йду, якщо закриваю очі чи просто в темноті можу впасти. Часто зашпортовуюсь та можу впасти.
3.	Я ознайомлений з вашим анамнезом життя та хвороби, для уточнення діагнозу мені необхідно вас оглянути, та провести деякі тести.	Добре
4.	Це камертон, я ним буду викликати вібрацію і ставити вам на кісткові виступи, якщо ви відчуваєте вібрацію, скажіть відчуваю, якщо перестали відчувати теж повідомте про це	Добре
5.	Якщо ви не проти я попрошу вас зняти взуття та лягти на кушетку.	Добре
6.	Прикладає камертон до кісткових виступів і питає «Відчуваєте вібрацію?»	Коли тестує на верхніх кінцівках відчуваєте близько 5 секунд, на нижніх кінцівках не відчуваєте
7.	Враховуючи дані анамнезу, скарг та неврологічного огляду я можу запідозрити у вас ураження задніх стовпів спинного мозку, що є досить характерним для нейроцифлісу.	Зрозуміло, що мені далі робити?

8.	Для остаточного підтвердження діагнозу і призначення необхідної терапії я скерую вас проконсультуватися з дерматовенерологом.	Добре, дякую
9.	На наступну консультацію до мене можете записатись за неефективності лікування, чи якщо раптом будуть прогресувати симптоми слабкості в ногах чи з'явиться біль. Чи є у вас запитання?	Ні, дякую до побачення.
10.	До побачення	

№	Лікар	Пацієнт
1.	Добрий день, мене звати ..., я лікар невропатолог. Як я можу до вас звертатись?	Добрий день, мене звати Юля.
2.	Юлія, розкажіть будь ласка що вас турбує?	Мене турбує сильна слабкість в ногах, коли ходжу в мене відчуття ніби я не відчуваю де я йду, якщо закриваю очі чи просто в темноті можу впасти. Часто зашпортуюсь та можу впасти.
3.	Я ознайомлений з вашим анамнезом життя та хвороби, для уточнення діагнозу мені необхідно вас оглянути, та провести деякі тести.	Добре
4.	Це камертон, я ним буду викликати вібрацію і ставити вам на кісткові виступи, якщо ви відчуваєте вібрацію, скажіть відчуваю, якщо перестали відчувати теж повідомте про це	Добре
5.	Якщо ви не проти я попрошу вас зняти взуття та лягти на кушетку.	Добре
6.	Прикладає камертон до кісткових виступів і питає «Відчуваєте вібрацію?»	Коли тестує на верхніх кінцівках відчуваєте близько 5 секунд, на нижніх кінцівках не відчуваєте
7.	Враховуючи дані анамнезу, скарг та неврологічного огляду я можу запідозрити у вас ураження задніх стовпів спинного мозку, що є досить характерним для нейросифілісу.	Зрозуміло, що мені далі робити?
8.	Для остаточного підтвердження діагнозу і призначення необхідної терапії я скерую вас проконсультуватися з дерматовенерологом.	Добре, дякую
9.	На наступну консультацію до мене можете записатись за неефективності лікування, чи якщо раптом будуть прогресувати симптоми слабкості в ногах чи з'явиться біль. Чи є у вас запитання?	Ні, дякую до побачення.
10.	До побачення	